

Fecha Última Actualización: 19-01-2026 16:51:34

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Matias Felipe Ortiz Mariqueo

Rut : 19.752.225-9

N° Archivo : 1033927

N° Epicrisis

469333

Edad : 28a 5m 24d

Fecha Nacto: 26/07/1997

Sexo : Masculino

Dirección : Soldado Zúñiga 13749 Ignacio Carrera Pin

Comuna : La Pintana

Teléfono : 966840559

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 04/01/2026 16:46

Días Estadía: 15

Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Egreso : 19/01/2026 16:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Herida arma de fuego

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES:

AM: fractura de antebrazo y clavícula derecha a los 13 años de manejo ortopédico, fractura húmero proximal izquierdo
Cx: fractura expuesta de fíbula izquierda por bala (escopeta) en 2014, con aseos quirúrgicos múltiples e injerto colgajo soleo.
Alergias: Niega
Medicamentos: Niega
Hábitos: TBQ (-) OH (-) Drogas (-)

HISTORIA:

Paciente recibe primera atención en SAPU Bernardo Leighton tras ser encontrado en via publica por transeúnte quien lo traslada al centro asistencial.
Ingresa a REA en regulares condiciones, hipotenso, daiforético, shock index >1, E-FAST (-) en dos ocasiones.
Se activa protocolo transfusión masiva.
Angiotac TAP con lesiones en ambos hemitórax, bazo, riñón e hígado con aire libre en abdomen.
Ingresa a pabellón donde se realiza instalación de pleurostomía bilateral + Laparotomía exploradora. En protocolo destaca como hallazgos: Hematoma retroperitoneal en zona II izquierda, que se expande a zona II derecha + Lesión esplénica + Lesión diafragmática izquierda de aprox 0.5 cm + Hematoma en relación a 2da y 3era porción de duodeno + Hematoma en cola de páncreas.
Ingresa a UCI para continuar manejo.

Diagnósticos de ingreso:

- 1) Shock hemorrágico
- 2) Herida tóraco abdominal por arma de fuego
 - a. Hemoneumotórax bilateral - Pleurostomía bilateral (04/01)
 - b. Laceración bazo con sangrado activo Laceración del segmento VI hepático, laceración cortical en polo superior de riñón derecho, lesión diafragma izquierdo ¿ Laparotomía exploradora: Esplenectomía, rafia diafragma, drenaje celda esplénica (04/01)
- 3) AKI KDIGO I
- 4) Antecedentes

Fecha Epicrisis : 19/01/2026 16:51

Página 1 de 3

EVOLUCIÓN

Paciente permanece en UCI hasta 09/01/26, posteriormente traslado a sala de cirugía donde permanece hasta alta. Durante estadia evoluciona con HDN autosostenida, sin conflicto perfusional, extubado 07/01/26, sin conflicto, se retiran pleurostomía derecha y izquierda el 08/01/26 y 11/01/26 respectivamente.

Desde lo infeccioso afebril, con PPII a la baja, mantiene cobertura ATB de foco abdominal con Ceftriaxona/Metronidazol hasta 15/01/26 donde destaca aumento de parámetros inflamatorios asociado TAC TAP que informa colección subdiafragmática de 54 mm en su diámetro mayor, en este contexto se decide escalar a ampicilina/sulbactam + drenaje de colección bajo ecografía por Dra. Mege el 16/01/26 donde da salida a 170 cc de contenido pancreático, cultivos rechazados. Se mantiene con drenaje hasta alta.

Evoluciona con disfagia + disfonía severa a moderada en seguimiento por fonoaudiología con indicaciones de Régimen blando sin granos y líquidos claros con bombilla, alimentación supervisada, sentado, lento, utilizando cuchara metálica pequeña y 3 degluciones por bolo, IC a ORL por disfonía severa/moderada de difícil recuperación la cual se tramitara de manera ambulatoria.

Además destaca diagnóstico de trastorno por estrés postraumático secundario a eventos ocurridos en el periodo de privación de libertad. Evaluado por psiquiatría con indicación de control en salud mental de su consultorio para continuidad de tratamiento y ajuste farmacológico.

Se decide alta y control ambulatorio.

Diagnóstico de Egreso

AGRESION CON DISPARO DE OTRAS ARMAS FUEGO Y LAS NO ESPECIFICADAS -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

En buenas condiciones generales, dolor bien controlado, afebril.

Diagnóstico de egreso

- 1) Shock hemorrágico resuelto
- 2) Herida tórax abdominal por arma de fuego
 - a. Hemoneumotórax bilateral - Pleurostomía bilateral (04/01). Derecha retirada 08/01/26/ Izq 11/01/26
 - b. Laceración bazo con sangrado activo Laceración del segmento VI hepático, laceración cortical en polo superior de riñón derecho, lesión diafragma izquierdo ¿ Laparotomía exploradora: Esplenectomía, rafia diafragma, drenaje celda esplénica (04/01)
- 3) AKI KDIGO I en recuperación
- 4) Retención aguda de orina resuelta
- 5) Trastorno de estrés post-traumático
- 6) Disfonía moderada a severa
- 7) Antecedentes

Plan Post Alta

- Régimen blando sin granos y líquidos claros con bombilla. Comer sentado, lento, utilizando cuchara metálica pequeña y 3 degluciones por bolo
- (*) Realizar rutina de ejercicios de fonoaudiología 3 veces al día (Terapia de voz + deglución)
- Reposo relativo
- No hacer fuerzas. Reposo deportivo por 3 semanas
- Fármacos:
 - * Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 8 horas vía oral por 7 días
 - * Metamizol 300 mg, 1 comprimido cada 8 horas vía oral por 5 días
 - * Ketoprofeno 100 mg, 1 comprimido cada 8 horas vía oral por 3 días
 - * PEG 1 sobre en 200 cc de agua SOS en caso de ausencia de deposiciones, máximo cada 8 horas por 3 a 5 días
 - * Escitalopram 10 mg, 1 comprimido cada 24 horas en la mañana vía oral por 30 días
 - * Quetiapina 25 mg, 1 comprimido cada c/12h vía oral por 30 días
 - * En caso de angustia/insomnio: quetiapina, 1 comprimido 25 mg SOS
 - * Amoxicilina/ Ac clavulánico 500/125 mg, 1 comprimido cada 8 horas vía oral por 14 días
 - * Pregabalina 75 mg, 1 comprimido cada 24 horas vía oral por 1 mes, tomar en la noche
 - * Aspirina 100 mg, 1 comprimido cada 24 horas vía oral por 1 mes
 - * Omeprazol 20 mg, 1 comprimido cada 24 horas vía oral en la mañana por 1 mes

Fecha Epicrisis : 19/01/2026 16:51

Fecha Última Actualización: 19-01-2026 16:51:34

Página 3 de 3

- Mantener drenaje, cuantificar y traer anotado débitos a control médico
- Control con Dra. Mege el miércoles 21/01/26 a las 10:00 AM en ecografía
- Control con Dra. Bustos en CDT pasillo 11 el jueves 29/01/26 a las 11:30, traer epicrisis
- Consultar en Servicio de Urgencias en caso de dolor abdominal intenso, fiebre, vómitos, mala tolerancia oral, o en caso necesidad.
- Mantener parches limpios y secos, usar secador de pelo sobre parches luego de ducha. No aplicar jabón, alcohol, cremas ni otras sustancias tópicas

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Blando Sin Granos + Líquidos Claros

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Bec. Beatriz Bustos Basaure

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)